



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACADEMICO DE CIRUGIA

SILABO CIRUGÍA I

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: CLINICA
- 1.2. Facultad: MEDICINA
- 1.3. Departamento académico: CIRUGIA
- 1.4. Programa/carrera profesional: MEDICINA
- 1.5. Sede/Filial: CENTRAL TRUJILLO
- 1.6. Año y semestre académico: 2025.
- 1.7. Ciclo: Quinto año.
- 1.8. Código de la Asignatura: 3686.
- 1.9. Sección(es) / grupo(s): 05 GRUPOS
- 1.10. Créditos: 07
- 1.11. Pre requisito: Medicina I
- 1.12. Inicio - Término: 03/03/2025 al 15/12/2025
- 1.13. Tipo: (Obligatorio/electivo) Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 32 semanas

ACTIVIDADES	Total de horas	UNIDADES			
		I	II	III	IV
Teoría	32	8	8	8	8
Prácticas presenciales	140	35	35	35	35
Retroalimentación	4	1	1	1	1
TOTAL HORAS	176				

1.15. Docente / Equipo docente(s):

Condición	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Mg. Alan Sánchez Medina	Medico Cirujano	asanchezm@unitru.edu.pe
Docente 1	Dr. Ronald Uriol Valverde	Medico Cirujano	ruriol@unitru.edu.pe
Docente 2	Mg. Ytalo Lino González	Medico Cirujano	ylino@unitru.edu.pe



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACADEMICO DE CIRUGIA

Docente 3	Dr. Félix Díaz Vera	Medico Cirujano	fdiaz@unitru.edu.pe
Docente 4	Dr. Jesús Ríos Mauricio	Medico Cirujano	jrios@unitru.edu.pe
Docente 5	Dr. Sandro Rodríguez Vásquez	Medico Cirujano	srodriguezv@unitru.edu.pe
Docente 6	Mg. Luis Salazar Briceño	Medico Cirujano	lsalazar@unitru.edu.pe
Docente 7	Mg. Eduardo Sifuentes Quiñones	Medico Cirujano	jsifuentes@unitru.edu.pe
Docente 7	Dr. Guillermo García Pérez	Medico Cirujano	ggarcia@unitru.edu.pe
Docente 8	Dr. Julio Gamarra Sánchez	Medico Cirujano	jegamarra@unitru.edu.pe
Docente 9	Mg. Carlos Arriaga Caballero	Médico Cirujano	carriaga@unitru.edu.pe
Docente 10	Mg. José Rivertte Chico	Médico Cirujano	jrivertte@unitru.edu.pe
Docente 11	Mg. Roberto Espinoza Llerena	Médico Cirujano	respinoza@unitru.edu.pe
Docente 12	Mg. Freddy Fernández Villacorta	Médico Cirujano	ffernandezv@unitru.edu.pe
Docente 13	Mg. Teófilo Chávez Domínguez	Medico Cirujano	tchavez@unitru.edu.pe
Docente 14	Mg. Daidy Barreto Vera	Médico Cirujano	dbarretov@unitru.edu.pe
Docente 15	Mg. William Sandoval Burgos	Médico Cirujano	wsandoval@unitru.edu.pe
Docente 16	Mg. Carlos Arriaga Verastegui	Médico Cirujano	carriagav@unitru.edu.pe
Apoyo	Sra. Pilar Hidalgo Guillena	Secretaria	phidalgo@unitru.edu.pe



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACADEMICO DE CIRUGIA

II. SUMILLA

- ✓ La asignatura de Cirugía I es presencial y de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar las unidades de competencias generales y contribuye directamente al logro de las capacidades específicas del perfil de egreso.
- ✓ Para el logro de estas competencias en CIRUGIA I se ha organizado el desarrollo de cuatro unidades: Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología y Cirugía de Tórax y Cardiovascular.
- ✓ La asignatura, será útil para que el estudiante diseñe soluciones para satisfacer necesidades en los aspectos de salud pública y aspectos quirúrgicos alineadas a las políticas de desarrollo local, regional y nacional, así como aplicar los conocimientos de ciencias en la solución de problemas en su práctica profesional.
- ✓ Asume un compromiso responsable con la vida, la dignidad humana, el cuidado de sí mismo, las personas (pacientes y familiares), las otras especies y el entorno social. La virtualidad se utilizará excepcionalmente; sin embargo, se podrá emplear como herramienta para la enseñanza-aprendizaje en las diversas actividades docentes.

Área: Estudios específicos

Naturaleza: Mixto

Propósito: Competencias y capacidades del perfil de egreso

Contenidos: Organizados en unidades temáticas

III. COMPETENCIAS

- **COMPETENCIAS GENERALES**

1. **COMUNICACIÓN:** Interactúa con diferentes grupos humanos, en diversos escenarios, mediante una comunicación clara y efectiva con ética y responsabilidad social.
2. **TRABAJO EN EQUIPO:** Trabaja en forma colaborativa e interdisciplinar para el logro de las metas, asumiendo el rol que le corresponde y respetando las decisiones tomadas. Calidad humana para brindar servicio y ayuda al prójimo Salud emocional y disposición para relacionarse con el personal de salud, paciente y familiar, con cortesía, mística y respeto.
3. **RESPONSABILIDAD EN ESCENARIOS DE TRABAJO:** Cumple con las normas de los escenarios de trabajo. Mantiene las formas adecuadas en su vestimenta como profesional médico en los escenarios de trabajo. Puntualidad y permanencia de acuerdo con la exigencia de su actividad programada.



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACADEMICO DE CIRUGIA

• **COMPETENCIAS ESPECIFICAS**

1. Promueve estilos de vida saludable para el logro de cambios en el perfil epidemiológico a nivel local, regional y nacional, con enfoque de interculturalidad.
2. Realiza actividades de prevención y promoción en el proceso de salud del paciente y la población.
3. Interviene en acciones de prevención y promoción de la salud ante factores de riesgo aplicando la epidemiología de las enfermedades emergentes y reemergentes.
4. Vigila el comportamiento del proceso salud-enfermedad en relación con las enfermedades de notificación en el contexto local, regional, nacional y mundial.
5. Vigila y previene los riesgos en desastres naturales o contingencias epidemiológicas.
6. Maneja la normatividad vigente para otorgar certificados de nacimiento y defunción.
7. Maneja elementos necesarios para elaborar la historia clínica de manera pertinente en cada caso.
8. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente en las diferentes áreas clínico-quirúrgicas de acuerdo al marco legal del ejercicio profesional.
9. Sustenta e interpreta resultados de exámenes de laboratorio y de imágenes solicitados para el diagnóstico, evolución y pronóstico de enfermedades.
10. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente de enfermedades propias del adulto mayor.
11. Diagnóstica, trata y recupera al paciente con enfermedades emergentes y reemergentes en el ámbito local, regional y nacional.
12. Explica el fundamento y la aplicación de la cirugía no invasiva en el tratamiento de patología benigna y maligna.
13. Solicita interconsultas sustentadas a nivel de mayor complejidad.
14. Realiza la referencia y contra referencia oportuna trabajando en red multi, inter y transdisciplinaria.
15. Elabora informes médicos de acuerdo a su nivel de competencia.
16. Realiza actividades de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en el proceso salud-enfermedad utilizando herramientas tecnológicas de actualidad en cirugía, así mismo las urgencias y emergencias.
17. Identifica problemas a partir de la observación de la realidad en ámbitos de salud de la población para plantear investigaciones.
18. Selecciona y analiza en forma crítica la información científica relevante y la utiliza en el diseño de proyectos de investigación.
19. Diseña y ejecuta proyectos de investigación usando el método científico para resolver problemas de salud a nivel local, regional, nacional y mundial.
20. Publica los resultados de la investigación en revistas indexadas.
21. Difunde los resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales.
22. Utiliza adecuadamente herramientas informáticas y tecnológicas de actualidad e idiomas extranjeros.

IV. PROGRAMACION ACADEMICA



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACADEMICO DE CIRUGIA

CLASE INAUGURAL: SOCIALIZACION DEL SILABO Y BIOSEGURIDAD

SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL SILABO 2025 Y BIOSEGURIDAD EN CIRUGIA			
COMPETENCIA: Conoce el silabo de cirugía 2025, así como los conceptos actuales de bioseguridad frente a las diversas epidemias que comprometen hospitales y la comunidad.			
Contenidos	Evidencias de desempeño	Técnica o Estrategia de aprendizaje	Resultados de aprendizaje
- Socializar el desarrollo de las actividades del silabo, así como sus formas de evaluación. - Estrategias de bioseguridad en los diferentes servicios y contextos de atención medica quirúrgica.	- Conoce y aplica las estrategias de bioseguridad generales y específicas. - Adopta medidas de bioseguridad frente a pacientes quirúrgicos.	Clase Teórica Magistral (Presencial)	- Demuestra habilidades, destrezas y competencias dentro de su nivel básico de complejidad con autonomía. - Flexibilidad para trabajar en equipo dentro de la normatividad bioética y necesidades básicas de atención quirúrgica necesaria para la comunidad. - Reconoce sus limitaciones y determina la referencia requerida en cada caso.



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

UNIDAD TEMATICA I: CIRUGIA GENERAL (Tiempo de rotación 9 días)

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANAS
Reconoce y orienta el manejo médico quirúrgico de la patología más frecuente en cirugía general demostrando responsabilidad, pertinencia y ética.	- Conoce la definición y la etiología, fisiopatología, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, diagnóstico diferencial. - Conoce y maneja el tratamiento médico y quirúrgico. - Reconoce las complicaciones y el pronóstico.	Tema 1: ABDOMEN AGUDO I: Peritonitis: definición, fisiopatología. Tema 2: ABDOMEN AGUDO II: Colecistitis aguda, Pancreatitis aguda y apendicitis aguda. Tema 3: ABDOMEN AGUDO III: Diverticulitis, Obstrucción intestinal y perforaciones gastrointestinales. Tema 4: QUEMADURAS Tema 5: CIRUGIA PEDIATRICA: patología más frecuente: abdomen agudo pediátrico, malformaciones congénitas más frecuentes: ano imperforado, hipertrofia pilórica, gastrosquisis, onfalocele y hernia diafragmática.	- Práctica Clínica - Técnica Quirúrgica - Clase presencial - Prueba parcial de unidad	- Informe caso clínico - Realiza técnica quirúrgica con simulación. - Examen de pre (opcional) y post test - Realiza prueba parcial de cirugía general.	- Rubrica de evaluación de la Práctica Clínica. - Rubrica de evaluación de la técnica quirúrgica. - Examen de pre (opcional) y post test - Examen parcial presencial.	Primera Semana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

Visado

UNIDAD TEMATICA II: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA (Tiempo de rotación 9 días)

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANAS
Reconoce y orienta el manejo médico quirúrgico de la patología mas frecuente en ortopedia y traumatología demostrando responsabilidad, pertinencia y eticidad.	• Conoce la definición y la etiología, fisiopatología, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, diagnóstico diferencial. • Conoce y maneja el tratamiento médico y quirúrgico. • Reconoce las complicaciones y el pronostico.	Tema 6: HISTORIA CLINICA en ortopedia y traumatología. Tema 7: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL: displasia de la cadera Tema 8: ENFERMEDADES INFECCIOSAS: osteomielitis, tuberculosis ósea y artritis séptica Tema 9: MANEJO INICIAL DE LUXACIONES Y COMPLICACIONES: hombro, codo y cadera. Tema 10: MANEJO INICIAL DE FRACTURAS Y COMPLICACIONES: radio distal, clavícula y fémur proximal	1. Práctica Clínica 2. Técnica Quirúrgica 3. Clase presencial 4. Prueba parcial de unidad	• Informe caso clínico • Realiza técnica quirúrgica con simulación. • Examen de pre (opcional) y post test • Realiza prueba parcial de cirugía general.	• Rubrica de evaluación de la Práctica Clínica. • Rubrica de evaluación de la técnica quirúrgica. • Examen de pre (opcional) y post test • Examen parcial presencial.	Segunda Semana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

Visado

UNIDAD TEMATICA III: ANESTESIOLOGIA (Tiempo de rotación 9 días)

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANAS
Reconoce y orienta el manejo anestesiológico de las patologías quirúrgicas en sala de operaciones demostrando responsabilidad, pertinencia y eticidad.	- Definición los diferentes tipos de anestesia. Los fármacos usados y su mecanismo de acción. Esquemas de manejo de los posibles efectos adversos y sus complicaciones. - Conceptos de paro cardio-respiratorio y cerebral, hipoxia oxigenación, manejo de la vía aérea. Estrategia de atención en los casos de parada cardiaca (RCPC). Escenarios clínicos de no realizar o suspender la RCPC.	Tema 12: EVALUACION PREANESTESICA: Examen clínico, scores preoperatorios, ayuno preoperatorio, pre-medicación. Tema 13: ANESTESIA LOCO REGIONAL: Anestesia raquídea, anestesia epidural. Tema 14: ANESTESIA GENERAL INHALATORIA Tema 15: ANESTESIA ENDOVENOSA (TIVA: Anestesia Total Intravenosa) Tema 16: REANIMACION CARDIOPULMONAR Y CEREBRAL (RCPC)	- Práctica Clínica - Técnica Quirúrgica - Clase presencial - Prueba parcial de unidad	- Informe caso clínico - Realiza técnica quirúrgica con simulación. - Examen de pre (opcional) y post test - Realiza prueba parcial de cirugía general.	- Rubrica de evaluación de la Práctica Clínica. - Rubrica de evaluación de la técnica quirúrgica. - Examen de pre (opcional) y post test - Examen parcial presencial.	Tercera Semana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

Visado

UNIDAD TEMATICA IV: CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR (Tiempo de rotación 9 días)

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANAS
Reconoce y orienta el manejo médico quirúrgico de la patología mas frecuente en cirugía de tórax y cardiovascular demostrando responsabilidad, pertinencia y eticidad.	- Conoce la definición y la etiología, fisiopatología, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, diagnóstico diferencial. - Conoce y maneja el tratamiento médico y quirúrgico. - Reconoce las complicaciones y el pronóstico.	Tema 17: EMERGENCIAS: trauma torácico y taponamiento cardiaco. Tema 18: ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA OBSTRUCTIVA Tema 19: TRASTORNOS VENOSOS: insuficiencia venosa.	- Práctica Clínica - Técnica Quirúrgica - Clase presencial - Prueba parcial de unidad	- Informe caso clínico - Realiza técnica quirúrgica con simulación. - Examen de pre (opcional) y post test - Realiza prueba parcial de cirugía general.	- Rubrica de evaluación de la Práctica Clínica. - Rubrica de evaluación de la técnica quirúrgica. - Examen de pre y post test - Examen parcial presencial.	Cuarta Semana



Visado



ESTRATEGIAS DIDACTICAS:

La estrategia de enseñanza-aprendizaje del curso de Cirugía I estará basada en un enfoque socio-cognitivo, en el cual el docente actuará como facilitador para el desarrollo de las competencias profesionales del estudiante egresado.

1) PRACTICA PRESENCIAL:

- **INICIO:** La interacción entre docente y alumno tiene como finalidad conocer y realizar la historia clínica, abordar el posible tratamiento médico-quirúrgico y desarrollar el pensamiento clínico-quirúrgico del alumno, utilizando la estrategia del SNAPPS.
- **DESARROLLO:** De acuerdo con las normativas de las sedes hospitalarias, se permite la presencia de un máximo de 2 alumnos por paciente y 5 alumnos por docente tutor. Se emplearán estrategias sincrónicas y asincrónicas y se revisarán artículos de revistas o libros para consolidar el conocimiento sobre las patologías revisadas. Se llevará a cabo una reunión con el docente tutor para discutir los casos o cirugías analizados y evaluar sus posibles desenlaces.
- **CIERRE:** Se elaborará un informe de un caso clínico seleccionado por el alumno de los temas discutidos con el docente. La calificación se realizará de acuerdo con la rúbrica de evaluación.

2) CLASES PRESENCIALES:

- **INICIO:** Las clases se realizan con la asistencia de todos los estudiantes bajo la conducción de un docente. Tienen una duración de 60 minutos y se llevarán a cabo según la programación académica.
- **DESARROLLO:** En cada clase, el profesor aplicará un pretest opcional al inicio de la exposición del tema, compuesto por 5 a 10 preguntas que se considerarán para la evaluación de esta actividad. Los estudiantes podrán plantear sus preguntas o inquietudes después de la exposición, para lo cual deberán haber estudiado el tema previamente.
- **CIERRE:** Al término de la exposición, el docente aplicará el post test correspondiente de la exposición.

3) TÉCNICA QUIRÚRGICA:

- **INICIO:** Esta actividad está orientada al desarrollo y adquisición de destrezas, así como conocimientos básicos sobre procedimientos quirúrgicos, utilizando simuladores, maquetas o tecnología virtual.
- **DESARROLLO:** La actividad se llevará a cabo en forma grupal en la sala de destrezas o laboratorio de cirugía experimental de la facultad de medicina. Los grupos estarán conformados por un máximo de 10 alumnos y un tutor, con el objetivo de adquirir conocimientos y destrezas en las siguientes especialidades quirúrgicas:



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

ESPECIALIDAD	TEMAS
CIRUGIA GENERAL	Lavado de manos, sutura, instrumentación quirúrgica.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Vendajes e Inmovilizaciones: Inmovilización de fractura de tibia. Estudio radiológico de la displasia del desarrollo de la cadera. Fractura de pelvis: faja pélvica. Reducción de luxaciones. Codo, hombro y Cadera.
ANESTESIOLOGIA	Anestesia raquídea, Anestesia epidural.
CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	Examen vascular de miembros inferiores, Técnicas de drenaje pleural.

- **CIERRE:** Al terminar esta actividad, el docente calificará de acuerdo con la rúbrica de evaluación de cada especialidad.

4) EXAMEN PARCIAL DE UNIDAD:

- **INICIO:** Los estudiantes se distribuirán en grupos por unidad temática y estarán a cargo de un docente designado para cada unidad.
- **DESARROLLO:** Se tomará un examen de los temas de la unidad temática programada, que constará de 20 preguntas. El examen será presencial y tendrá una duración máxima de 30 minutos.
- **CIERRE:** Al finalizar el examen, este será entregado al docente para su respectiva calificación y posteriormente remitido a la jefatura del departamento

5) CURSO – TALLER: MANEJO INICIAL DEL TRAUMA

- **INICIO:** los estudiantes de la rotación recibirán una clase teórica, previo al desarrollo de cada tema del taller, la misma que estará a cargo del docente programado.
- **DESARROLLO:** el alumno debe realizar como mínimo 3 horas/semana.
Los temas deberán ser desarrollados por los alumnos en las siguientes semanas:
 1. Abordaje inicial de un Politraumatizado.
 2. Segunda semana: Evaluación y manejo de la vía aérea.
 3. Tercera semana: Evaluación y manejo del trauma torácico.
 4. Cuarta semana: Evaluación y manejo del trauma abdominal.
 5. Quinta semana: Evaluación y manejo del trauma pélvico.
 6. Sexta semana: RCP básico y avanzado.Se realiza un taller por cada unidad dirigido por un docente tutor en la sala de destrezas o aula de cirugía en la Facultad de Medicina, (grupo de 10 alumnos como máximo), con los alumnos divididos en 4 cuatro grupos
- **CIERRE:** Se evaluará el manejo inicial del trauma como parte del Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECO) en la sala de destrezas de la Facultad de Medicina.



Visado



V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: La evaluación de la actividad académica del alumno está regida por el Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje. Esta evaluación será permanente.

Procedimientos: La evaluación de los estudiantes será de tipo procesual, sumativa y continua. Los productos académicos de cada unidad temática tendrán una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados para cada herramienta. Esto nos dará una nota parcial de unidad que será promediada. A partir de un promedio simple de estas notas parciales, se obtendrá el promedio promocional final.

EVALUACIONES PARCIALES	PONDERACIÓN
1. Práctica clínica	40
2. Técnica Quirúrgica	10
3. Clase presencial	10
4. ECOE	15
5. Prueba final de unidad	25
PESO TOTAL	100%

Mediciones en evaluaciones integradoras

ECOE del Taller de Trauma: Es la forma de evaluar la competencia clínica de los estudiantes de Medicina de manera planificada (estructurada), prestando atención a la objetividad del examen. Consiste en una serie de etapas programadas (estaciones), a través de las cuales se desplaza el estudiante para cumplir una actividad clínica.

La competencia clínica permite medir la capacidad del educando en relación a sus conocimientos, habilidades, organización y cualidades interpersonales.

ALUMNO: Es el “actor” principal y el evaluado. Su accionar consiste en demostrar las habilidades y conocimientos adquiridos durante las rotaciones teórico-prácticas, actuando frente a pacientes simulados, maquetas, fotografías clínicas, radiografías, o desarrollando cuestionarios, por un espacio predeterminado de 4 minutos para desarrollar una estación clínica. En esta actividad clínica simulada, debe tener una actuación lo más realista posible para demostrar frente al evaluador (Docente) que tiene los conocimientos y aptitudes suficientes para llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento correcto, además de demostrar tener un esquema básico de conocimientos sobre el material o medicamentos necesarios para el manejo de las patologías a tratar.

Durante el desarrollo de la actividad clínica, no debe entablar diálogo con el docente evaluador, a menos que éste se lo solicite. La relación debe ser estrictamente médico-paciente.

DOCENTE: Es el evaluador del examen simulado. Su accionar está limitado a observar el accionar del alumno y anotar en una lista de cotejos, con una marca de SI o NO, según corresponda, de manera parcial. Se trata de un examen objetivo, donde todos los educandos tienen las mismas posibilidades de ser evaluados con la misma regla. El docente no interviene directamente en la acción misma del examen.

PACIENTE SIMULADO: Es la persona o maqueta con quien interactuará el alumno. Estará entrenada o simulará una lesión para que el alumno pueda desarrollar su estación clínica de la manera más real posible.



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

Coordinador: Es responsable de asegurar que el ECOE se desarrolle según lo programado y cumpliendo las normas correspondientes. Sus funciones incluyen:

- Preparar y guardar los paquetes de ECOE una semana antes de la fecha programada.
- Revisar con la secretaria el contenido de cada paquete de ECOE para asegurar que estén completos.
- Llevar los paquetes de ECOE una hora antes al lugar según la fecha y hora programadas.
- Revisar los ambientes donde se desarrollarán las estaciones y dar a conocer a cada docente su contenido.
- Colaborar con los docentes para colocar y distribuir las instrucciones en cada estación.
- Al finalizar el examen, recepcionar y calificar los exámenes para remitirlos al departamento de cirugía.

Criterios de evaluación del ECOE: El estudiante realizará dos pruebas ECOE. La primera prueba evaluará el manejo inicial de un paciente con trauma, mientras que la segunda prueba abarcará diversas especialidades del curso. Cirugía general, Ortopedia y traumatología, Cirugía cardiovascular y tórax y Anestesiología. La calificación de cada estación será sobre 100 puntos, que luego se promediarán y convertirán al sistema vigesimal para calcular la nota de cada unidad.

Criterios de promoción

- 1) El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es 14.
- 2) En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- 3) Con un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- 4) En el caso de los estudiantes aplazados, la nota obtenida se promediará con la nota promedio del ciclo regular.

Nivel de logro

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Los niveles de logro se determinan de la siguiente manera:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas (0-13).
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17).
- **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20).

Examen Sustitutorio

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio (menor a 14) pasarán a un examen sustitutorio que reemplazará a la nota más baja obtenida en las cuatro unidades. Solo se podrá realizar un examen para sustituir la nota de una unidad. El alumno desaprobado presentará un FUT al coordinador del curso de manera obligatoria, según la Resolución Vicerrectoral Académica 060-2021-VAC/UNT, que aprueba las orientaciones técnicas sobre el examen sustitutorio en los estudios de pregrado en la UNT.



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

El promedio promocional del alumno se realizará con la siguiente formula:

$$PP = (U1 + U2 + U3 + U4) / 4$$

Donde: PP: promedio promocional

U1, U2, U3, U4: unidades temáticas.

VI. TUTORÍA/ORIENTACION:

1. **Propósito:** Es el servicio de orientación y apoyo al estudiante en lo concerniente a su participación y rendimiento en la experiencia curricular.
2. **Desarrollo de la consejería:**
Días: Se realiza durante el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje como dimensión inherente a la misma.
Vías: Se llevará a cabo de forma presencial o virtual.

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA

Esta actividad se realizará durante el presente año según el acuerdo del pleno de docentes, en cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto Universitario y en beneficio de la comunidad elegida.

APRECIACION PERSONAL DEL ALUMNO SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CIRUGIA I.

Al término de su rotación, el alumno deberá llenar una encuesta sobre su apreciación de la rotación por cirugía y el compromiso de los docentes.

LINK: <https://forms.gle/UAzECPgHVrGQNGZd6>

VII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

CIRUGIA GENERAL

1. Márquez R. Cirugía General para el Médico General. 2° ed. Editorial McGraw-Hill. (2011). 280 pp. ISBN: 978-607-15-0552-1
2. Schwartz SI, Brunickardi C. Schwartz. Principios de Cirugía. 10° ed. Editorial Mc Graw Hill (2015). 2096 pp. ISBN: 978-607-15-1275-8
3. Townsend CM Jr., Sabiston. Cirugía general y del aparato digestivo. 19ª ed. Editorial Elsevier. (2014). 550 pp. ISBN: 978-849-02-2529-5
4. Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston. Tratado de Cirugía 20ª Ed. Editorial Elsevier. (2018). 2168 pp. ISBN: 978-84-9113-132-8
5. Caycedo B Rubén E. Cirugía general para el nuevo milenio. 3ª. ed. Editorial Medica Celsus. (2013). 828 pp. ISBN: 958-9327-37-1

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

1. Azar. Canale S. Beaty. Campbell's. Operative Orthopaedics. 13ª. Ed. Marban. (2017). 4225 pp. ISBN: 978-032-33-7462-0
2. Thompson A. Manual de inmovilizaciones y vendajes. Editorial Elsevier (2013). 320 pp. ISBN: 978-849-02-2012-2
3. Colegio Americano de Cirujanos. Steward R. Apoyo vital avanzado en trauma ATLS®. Manual del curso para estudiantes. 10° ed. Chicago. (2018). 406 pp. ISBN 78-0-9968262-3-5
4. Browner BD, Jupiter JB, Krettek C, Anderson PA. Trauma Esquelético. Ciencia Básica, Manejo y Reconstrucción. 5° ed. Editorial Amolca. (2017). 2648 pp. ISBN-13: 978-958-89-5036-5



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

ANESTESIOLOGIA:

1. Butterworth JF, Mackey D, Wasnick J. Anestesiología clínica de Morgan y Mikhail. 6ta Ed. México. El Manual Moderno, 2020
2. Ae A, MI L, Ee H. ASA Physical Status Classification System.
3. Barash P, Cullen B, Stoelting R. Fundamentos de Anestesia Clínica. 2da ed. España. Wolters Kluwer, 2022.
4. Acquisto NM, et al. Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines for Rapid Sequence Intubation in the Critically Ill Adult Patient. Critical Care Medicine [Internet]. octubre de 2023 [citado 24 de febrero de 2025];51(10):1411. Disponible en: https://journals.lww.com/ccmjjournal/fulltext/2023/10000/society_of_critical_care_medicine_clinical.14.aspx
5. American Heart Association. Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE. Dallas, Texas: American Heart Association; 2020.
6. JN-1090.
7. Berg KM, et al. Adult Advanced Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation [Internet]. 20 de octubre de 2020 [citado 24 de febrero de 2025];142(16_suppl_1). Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000893>
8. Alvarado Ferllini M. Secuencia de intubación rápida en el Servicio de Emergencias: una revisión bibliográfica. RCMUI [Internet]. 26 de octubre de 2021 [citado 24 de febrero de 2025];3(2). Disponible en: <https://www.unibe.ac.cr/ojs/index.php/RFMUI/article/view/66>
9. Olasveengen TM, Mancini ME, Perkins GD, Avis S, Brooks S, Castrén M, et al. Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation [Internet]. 20 de octubre de 2020 [citado 24 de febrero de 2025];142(16_suppl_1). Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000892>.
10. Cpr.heart.org [Internet]. [citado 24 de febrero de 2025]. Focused Updates. Disponible en: <https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/guidelines-updates-and-highlights>.
11. Apfelbaum JL, Hagberg CA, Connis RT, Abdelmalak BB, Agarkar M, Dutton RP, et al. 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway *. Anesthesiology [Internet]. enero de 2022 [citado 24 de febrero de 2025];136(1):31-81. Disponible en: <https://journals.lww.com/10.1097/ALN.00000000000004002>
12. Frerk C, Mitchell VS, McNarry AF, Mendonca C, Bhagrath R, Patel A, et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. British Journal of Anaesthesia [Internet]. diciembre de 2015 [citado 24 de febrero de 2025];115(6):827-48. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007091217314319>
13. Gómez-Ríos MÁ, et al. Guía de la Sociedad Española De Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) para el manejo de la vía aérea difícil. Parte I. Revista Española de Anestesiología y Reanimación [Internet]. marzo de 2024 [citado 24 de febrero de 2025];71(3):171-206. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034935623002608>
14. Gómez-Ríos MÁ, et al. Guía de la Sociedad Española De Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) para el manejo de la vía aérea difícil. Parte II. Revista Española de Anestesiología y Reanimación [Internet]. marzo de 2024 [citado 24 de febrero de 2025];71(3):207-47. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034935623002591>



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

CIRUGIA DE TORAX Y CARDIO VASCULAR

1. D. Sugarbaker. Cirugía de tórax. Editorial Médica Panamericana. (2011). 1248 pp. ISBN: 978-950-06-0142-9.
2. Cirugía de Tórax y cardiovascular. En: Schwartz. Principios de Cirugía. 10° ed. Editorial Mc Graw Hill (2015). 2096 pp. ISBN: 978-607-15-1275-8
3. Ferguson M. Atlas de Cirugía de Tórax. Editorial AMOLCA. (2009). 295pp. ISBN: 9789588473277

RECURSOS VIRTUALES DE APOYO

1. Pautas CARE para la realizar el informe de casos clínicos en la investigación de salud. <https://www.care-statement.org>
2. Base de datos PROQUEST artículos: <https://www.proquest.com/?accountid=200235>
3. Base de datos PROQUEST Libros: <https://ebookcentral.proquest.com/>
4. Base de datos GALE: <https://link.gale.com/apps/menu?u=unt>
5. Reyes Abarca, C., & Moreno Bolton, R. (2007). Enseñanza centrada en el estudiante. *ARS MEDICA Revista De Ciencias Médicas*, 7(1), 107–119. <https://doi.org/10.11565/arsmed.v36i2.150>
6. González-Flores P, Luna de la Luz V. La transformación de la educación médica en el último siglo: innovaciones curriculares y didácticas (parte 1). *Inv Ed Med*. 12 de abril de 2019;30(2):95-109. <http://dx.doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.30.18165>

DRIVE DE BIBLIOGRAFIA DIGITAL:

https://drive.google.com/drive/folders/15jPpuY7XEJ9ri96u7fTVJrm0v-bQ_kEt?usp=sharing



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

LINK RUBICAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1AAz777wN2trILci42UvyaVrXUOPRgZ7q?usp=drive_link

ANEXO 1

RUBRICAS DE EVALUACIÓN

PRACTICA CLINICA

CRITERIOS	NIVEL III	NIVEL II	NIVEL I	Nivel 0	PUNTAJE
Tema, objetivos, desarrollo del caso clínico	El alumno conoce los casos clínicos y presenta un razonamiento clínico ordenado sistematizado, con información actual y de acuerdo al sistema SNAPPS. (5)	El alumno conoce parcialmente los casos clínicos y/o su razonamiento clínico está en proceso de ordenarse de acuerdo al sistema SNAPPS. (3)	El alumno no conoce el caso clínico desarrollado y no presenta un adecuado razonamiento clínico. (1)	El alumno no desarrolla los temas. (0)	
La calidad de discusión clínica	La discusión de los casos clínicos y las ideas presentadas son coherentes, claras y actuales. (5)	La discusión de los casos clínicos y/o las ideas presentadas son parcialmente coherentes. (3)	La discusión de los casos clínicos y las ideas presentadas son muy pobres y no claras. (1)	El alumno no participa en la discusión de los casos clínicos. (0)	
Calidad del informe del caso clínico de acuerdo al sistema SNAPPS	El caso clínico presenta coherencia y orden de acuerdo al sistema SNAPPS. (5)	El caso clínico presenta poco orden y/o coherencia parcial de acuerdo al sistema SNAPPS. (3)	El caso clínico no tiene orden ni coherencia. (1)	El alumno no presenta el caso clínico. (0)	
Evaluación actitudinal.	Es puntual, respetuoso con pacientes y docente, usa vestimenta adecuada. (5)	Falta 01 reunión o 02 tardanza o no usa vestimenta adecuada. (3)	Falta a 02 reuniones o 03 tardanzas. (1)	No asiste a las reuniones con el docente. (0)	
PUNTAJE TOTAL:					



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

CLASE PRESENCIAL

CRITERIOS	NOTAS			
APLICACIÓN DE PRE Y POST TEST	PRE + POST = PROMEDIO			
NIVEL DE LOGRO	Avanzado (18-20)	Intermedio (15-17)	Proceso (11-14)	Inicio (0-10)

El alumno que no realice esta actividad, será calificado con nota cero (00).



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA GENERAL

CRITERIOS	NIVEL III	NIVEL II	NIVEL I	PUNTAJE
Se coloca los guantes estériles.	El alumno respeta los lineamientos de asepsia antisepsia. (2)	El alumno no respeta los lineamientos de asepsia antisepsia. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Coloca la anestesia local.	El alumno infiltra la herida por su borde interno y paralela al eje mayor. (3)	El alumno no infiltra la herida por su borde interno y/o no es paralela al eje mayor. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Elige el material de la sutura.	El alumno elige el material de acuerdo al tejido a afrontar. (3)	El alumno no elige el material de acuerdo a la estructura a afrontar. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Carga la aguja en el porta agujas.	Toma la aguja en la unión de su tercio proximal y medio con el extremo del porta agujas. (3)	Toma la aguja en cualquier parte de la aguja y parte del extremo del porta agujas. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Realiza el movimiento rotacional de la mano.	El alumno realiza el movimiento rotacional de la mano siguiendo la curvatura de la aguja. (3)	El alumno realiza el movimiento rotacional de la mano, pero no sigue la curvatura de la aguja. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Realiza la lazada en los puntos simples.	El alumno realiza la lazada formando un nudo cuadrado. (3)	El alumno realiza la lazada no logrando formar un nudo cuadrado. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Coloca apósitos estériles sobre la sutura realizada.	El alumno cubre la totalidad de la herida con un apósito estéril y lo fija con esparadrapo. (3)	El alumno cubre parcialmente la herida con un apósito estéril y/o no lo fija con esparadrapo. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
PUNTAJE TOTAL:				



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

CRITERIOS	NIVEL III	NIVEL II	NIVEL I	PUNTAJE
Pregunta ¿cuándo, dónde, qué, cuál? Con respecto a la fractura de pierna simulada.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Inspecciona o hace reconocimiento de la lesión en pierna y coloca anestesia local.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Alinea la extremidad y coloca acolchado con algodón las prominencias óseas (cabeza de peroné, maléolos y cóndilos femorales).	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y el acolchado cubre las zonas prominentes. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o el acolchado no cubre las zonas prominentes. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Coloca dos férulas, una en la parte medial y la otra en la parte lateral de la pierna fracturada.	El alumno realiza la actividad de manera completa y usa férulas de tamaño adecuado. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o usa férulas de tamaño no adecuado. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Desliza adecuadamente la venda elástica de distal a proximal.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y la cobertura del vendaje es adecuado. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o la cobertura del vendaje no es adecuado. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Inmoviliza articulaciones próximas a la lesión (rodilla y tobillo).	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Revisa la forma final de la inmovilización.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
PUNTAJE TOTAL:				



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE ANESTESIOLOGIA

CRITERIOS	NIVEL III	NIVEL II	NIVEL I	PUNTAJE
Comunica al paciente el procedimiento a realizar y coloca en posición adecuada.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Se coloca los guantes estériles.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Hace la asepsia y antisepsia de la región lumbar.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Localiza el espacio intervertebral.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Coloca adecuadamente la aguja de punción lumbar Nº 27 en la aguja guía. (puede usar solo una aguja).	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Introduce la aguja de punción lumbar en el espacio intervertebral. Explicando los planos que atraviesa.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Espera la salida del líquido cefalorraquídeo (3 segundos).	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Administra la solución anestésica adecuada y retira la aguja.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
PUNTAJE TOTAL:				



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA
DPTO. ACAD. CIRUGIA

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR

CRITERIOS	NIVEL III	NIVEL II	NIVEL I	PUNTAJE
Comunica al paciente el procedimiento a realizar.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (2)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (1)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Se coloca guantes descartables para realizar el examen.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Inspección: observa y comenta si hay diferencia de volumen, color o presencia de lesiones en ambos miembros inferiores	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Palpación: palpa la temperatura en forma segmentaria y comparativa, en ambos miembros inferiores.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Palpan los pulsos arteriales periféricos: femoral, poplíteo, tibial posterior y pedio.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Describe semiológicamente los pulsos: ritmo, intensidad, frecuencia, si hay dicotismo.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
Informa al paciente sobre los hallazgos.	El alumno realiza la actividad de manera ordenada y completa. (3)	El alumno realiza la actividad incompleta y/o desordenada. (2)	El alumno no realiza la actividad. (0)	
PUNTAJE TOTAL:				



Visado



ECOE (EXAMEN CLINICO OBJETIVO ESTRUCTURADO):

1. RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL TALLER MANEJO INICIAL DEL TRAUMA

ESTACIONES	RUBRICA DE EVALUACION	PUNTAJE
1. EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO	LISTA DE COTEJO	
2. MANEJO DE LA VIA AEREA	LISTA DE COTEJO	
3. MANEJO DEL TRAUMA ABDOMINAL	LISTA DE COTEJO	
4. MANEJO TRAUMA VASCULAR	LISTA DE COTEJO	
5. MANEJO DE TRAUMA PELVICO	LISTA DE COTEJO	
6. RCP BASICO	LISTA DE COTEJO	

2. RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL ECOE GENERAL DE CIRUGIA

ESTACIONES	RUBRICA DE EVALUACION	PUNTAJE
EVALUACIÓN ABDOMEN AGUDO	LISTA DE COTEJO	
EVALUACION DE UN QUEMADO	LISTA DE COTEJO	
REDUCCION DE UNA LUXACION DE HOMBRO (MANIOBRA DE KOCHER)	LISTA DE COTEJO	
ANESTESIA RAQUÍDEA	LISTA DE COTEJO	
TORACOCENTESIS	LISTA DE COTEJO	